szczepienia.info



Przewodnik

PO SZCZEPIENIACH

dla kobiet w ciąży

Ministerstwo Zdrowia

NPZ NARODOWY PROGRAM ZDROWIA

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.

© Copyright by Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH –
Państwowy Instytut Badawczy, 2025

Przedruk materiałów w całości lub części możliwy jest wyłącznie
za zgodą Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH –
Państwowego Instytutu Badawczego

Cytowanie i wykorzystanie danych empirycznych dozwolone za podaniem źródła

ISBN: 978-83-65870-95-7

Opracowanie graficzne i skład:
Studio Grafpa

Wydawca
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
tel. +48 22 54 21 400, +48 22 54 21 200
e-mail: wydawnictwo@pzh.gov.pl

2025

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Spis treści

1. WSTĘP 4

2. OGÓLNIE O SZCZEPIENIACH OCHRONNYCH KOBIET W CIĄŻY 6

3. SZCZEPIENIE PRZECIW GRYPIE 17

4. SZCZEPIENIE PRZECIW KRZTUŚCOWI 23

5. SZCZEPIENIE PRZECIW RSV 31

6. SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19 35

7. WIĘCEJ ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ KOBIET W CIĄŻY 40

8. JAK ROZMAWIAĆ Z PRACOWNIKIEM MEDYCZNYM O SZCZEPIENIACH W OKRESIE CIĄŻY? 43

9. PIŚMIENNICTWO 52

1. Wstęp



Drogie przyszłe Mamy,

Ciąża to wyjątkowy, unikalny czas, w którym opieki wymaga nie tylko zdrowie przyszłej Mamy, ale również zdrowie dziecka, stąd też i odpowiedzialność jest podwójna.

Wraz z fizjologicznymi zmianami organizmu przyszłej Mamy, które gwarantują prawidłowy rozwój, obserwujemy istotne zmiany w zakresie odpowiedzi immunologicznej i działania układu immunologicznego przyszłej Mamy. To powoduje, że kobiety ciąży są narażone na cięższy przebieg wielu infekcji. Niekiedy banalna infekcja, czy przeziębienie trwa znacznie dłużej niż u kobiety, która nie jest w ciąży.

Szczepienia w ciąży to ważny element profilaktyki – chronią przyszłą mamę przed groźnymi infekcjami, a tym samym powikłaniami ciąży, ale jednocześnie (a może przede wszystkim) budują tarczę odpornościową dla maluszka w pierwszych miesiącach życia.

Jesteś w ciąży i zastanawiasz się nad szczepieniami? To naturalne, że chcesz podjąć najlepszą decyzję dla siebie i swojego dziecka.

W przewodniku opisujemy szczepionki, które zalecane są kobietom w ciąży oraz choroby, którym zapobiegają. Przypominamy dlaczego szczepionki są ważnym elementem utrzymania zdrowia.

Redakcja Szczepienia.info

2. OGÓLNIE O SZCZEPIENIACH OCHRONNYCH KOBIET W CIĄŻY

Dlaczego zaleca się szczepienia kobietom w ciąży?

Szczepienia zalecane w okresie ciąży zwiększają ochronę:

- Ciężarnej,
- Płodu,
- Dziecka w pierwszych miesiącach życia.

Dziecko po urodzeniu, a także w pierwszych miesiącach życia jest szczególnie narażone na choroby zakaźne, ponieważ jego układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni dojrzały, a ze względu na wiek nie ma jeszcze własnej odporności związanej ze szczepieniami.

Matka po szczepieniu w czasie ciąży wytwarza swoiste przeciwciała, które przekazuje przez łożysko dziecku, które w ten sposób dostaje gotową ochronę do walki z chorobami zakaźnymi. Można to nazwać swego rodzaju prezentem od matki dla dziecka, ponieważ dziecko dostaje gotowe przeciwciała, które pomagają ochronić je przed zakaźnymi patogenami po urodzeniu. Naukowcy nazywają to „ochroną bierną". Tak więc szczepienie w okresie ciąży chroni matkę i płód przed zachorowaniem, a dzięki transferowi przeciwciał przez łożysko, również dziecko w pierwszych miesiącach jego życia. Szczepienie kobiety w ciąży dodatkowo ogranicza transmisję zakażenia z matki na niemowlę, w pierwszych miesiącach jego życia.

Od jak dawna stosujemy szczepienia kobiet w ciąży?

Szczepienia kobiet w ciąży nie są nową koncepcją.

Znane są od lat 70. XX wieku.

Okres wprowadzenia	Szczepienie
Lata 70. XX wieku	Szczepienie kobiet w ciąży przeciw tężcowi.
Lata 2009-2010	Pandemia grypy A/H1N1 pokazała ryzyko grypy w ciąży i korzyści ze szczepienia przeciw grypie kobiet w ciąży.
Lata 2012-2015	Epidemia krztuśca w krajach Europy Zachodniej przypomniała ryzyko ciężkiego przebiegu krztuśca i zgonów u noworodków i niemowląt. Poznano dane na temat bezpieczeństwa i korzyści ze szczepienia Tdap przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi dla kobiety w ciąży i jej dziecka.
Lata 2020-2023	W czasie pandemii COVID-19 w wielu krajach rekomendowano stosowanie szczepionki mRNA dla kobiet w ciąży podkreślając ochronę kobiety w ciąży i jej dziecka.
Lata 2023-2024	Opracowano i wprowadzono do stosowania szczepionkę przeciw RSV. Podana w ostatnim trymestrze ciąży zapewnia ochronę niemowlęcia w pierwszych 6 miesiącach życia przed ciężkimi zakażeniami dolnych dróg oddechowych wywołanych przez RSV.

Obecnie szczepienia kobiet w ciąży są powszechną praktyką na całym świecie.

OKRES PRZED CIĄŻĄ

Jakie szczepienia zaleca się kobietom planującym ciążę?

Kobieta planująca ciążę powinna ustalić swój potencjalny status odporności przeciw chorobom zakaźnym na podstawie dokumentacji medycznej przebytych chorób zakaźnych lub historii szczepień wykonanych w przeszłości zapisanej w książeczce zdrowia dziecka.

Kobiecie planującej ciążę zaleca się:

Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B)

Dlaczego? Aby uniknąć zakażenia WZW B w okresie ciąży lub w czasie porodu.

Kto powinien się zaszczepić? Kobieta, która została w przeszłości zaszczepiona 3 dawkami szczepionki.

Ile dawek? 3 dawki w odstępach 0, 1, 6 mies.

Szczepienie przeciw różyczce

Dlaczego? Zakażenie wirusem różyczki podczas ciąży może prowadzić do szeregu wad wrodzonych u dziecka, które nazywamy zespołem różyczki wrodzonej.

Kto powinien się zaszczepić? Kobieta, która nie została w przeszłości zaszczepiona.

Ile dawek? 2 dawki w odstępie nie krótszym niż 4 tyg., szczepionką MMR przeciw odrze, śwince i różyczce.

Szczepienie przeciw ospie wietrznej

Dlaczego? Zakażenie ospą wietrzną kobiety w ciąży może prowadzić do trwałych uszkodzeń narządowych dziecka.

Kto powinien się zaszczepić? Kobieta, która nie chorowała na ospę wietrzną i nie była szczepiona.

Ile dawek? 2 dawki w odstępie nie krótszym niż 6 tyg., szczepionką przeciw ospie wietrznej.

Szczepienie przeciw grypie

Dlaczego? Grypa u kobiet w ciąży występuje częściej niż u innych osób. Może przebiegać z zaostrzeniem objawów oraz powikłaniami, co związane jest z koniecznością hospitalizacji.

Kto powinien się zaszczepić? Kobiety, które planują ciążę w czasie sezonu infekcyjnego grypy.

Kiedy i ile dawek? 1 dawka w czasie sezonu infekcyjnego, jeżeli ciąża lub poród przypada na okres nasilenia zachorowań na grypę.

Jak finansowane są szczepionki zalecane dla kobiet planujących ciążę?

Kobiety planujące ciążę, dotychczas nieszczepione przeciw WZW typu B, mają dostęp do bezpłatnego szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B).

Pozostałe zalecane szczepionki są odpłatne.

OKRES CIĄŻY

Jakie szczepionki są zalecane dla kobiet w ciąży?

- Kobietom w ciąży można bezpiecznie podawać szczepionki inaktywowane, inaczej zabite.
- Nie podaje się szczepionek żywych, z osłabionymi drobnoustrojami.

Kobieta w ciąży powinna zaszczepić się:

- przeciw grypie,
- przeciw krztuścowi,
- przeciw RSV,
- przeciw COVID-19.

Inne szczepionki inaktywowane mogą by podane w szczególnie uzasadnionych sytuacjach narażenia na zakażenie, np. szczepienia zalecane w medycynie podróży lub w określonych sytuacjach epidemicznych.

Szczepienia dla kobiet w ciąży w pigułce

Choroba	Zalecane szczepienie
Grypa u kobiet w ciąży występuje częściej niż u innych osób. Może przebiegać z zaostrzeniem objawów oraz powikłaniami, co związane jest z koniecznością hospitalizacji. Kobiety w ciąży i połogu, w porównaniu z kobietami niebędącymi w ciąży, częściej wymagały hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii.	**Szczepienie przeciw grypie.** Zapobiega zachorowaniom na grypę i jej powikłaniom oraz zapewnia bierną ochronę niemowlęcia przed grypą w pierwszych miesiącach życia. Można je wykonać w dowolnym trymestrze ciąży, najlepiej przed okresem zwiększonej zachorowalności na grypę. Szczepionka bezpłatna w ramach refundacji. Potrzebna recepta.

Choroba	Zalecane szczepienie
Krztusiec jest najbardziej niebezpieczny dla noworodków i niemowląt, które ze względu na wiek nie mają jeszcze w pełni wykształconej odporności, w tym związanej ze swoimi szczepieniami.	**Szczepienie przeciw krztuścowi.** Podawane w celu ochrony niemowlęcia przed krztuścem w pierwszych miesiącach jego życia. Szczepionka preparatem Tdap przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi z obniżoną zawartością składnika błonicy i krztuśca. Zalecana między 27. a 36. tyg. ciąży. W uzasadnionych przypadkach porodu przedwczesnego po ukończeniu 20. tyg. ciąży. Szczepionka bezpłatna. Szczepienie w POZ. Recepta niepotrzebna.
RSV (syncytialny wirus oddechowy) jest jedną z głównych przyczyn ostrych infekcji dróg oddechowych u małych dzieci. Szczególnie narażone są dzieci w 1. roku życia.	**Szczepienie przeciw RSV.** Podawane w celu zapewnienia ochrony przed zakażeniem dolnych dróg oddechowych wywołanych RSV u niemowląt w pierwszych 6 miesiącach życia. Zalecane kobietom od 24. do 36. tyg. ciąży, krótko przed rozpoczęciem lub w trakcie sezonu epidemicznego RSV. Szczepionka bezpłatna w ramach refundacji. Potrzebna recepta.
COVID-19 w ciąży wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby u matki, przyjęcia na oddział intensywnej terapii. Zwiększa ryzyko powikłań w przebiegu ciąży.	**Szczepienie przeciw COVID-19.** Zapewnia bierną ochronę niemowlęciu w pierwszych 6 miesiącach życia. Chroni również ciężarną. Szczepienie preparatem mRNA dostosowanym do aktualnie krążącego wariantu SARS-CoV-2. Szczepienie można wykonać w dowolnym okresie ciąży, najlepiej w II lub III trymestrze. Szczepionka bezpłatna. Recepta na szczepionkę niepotrzebna. Szczepienie w punktach szczepień przeciw COVID-19.

Kto zaleca szczepienia dla kobiet w ciąży?

Szczepienie ciężarnych określonymi preparatami jest powszechną praktyką na całym świecie.

Szczepienia dla kobiet w ciąży zalecają liczne towarzystwa naukowe, komitety doradcze ds. szczepień ochronnych, instytucje zdrowia publicznego oraz międzynarodowe organizacje zajmujące się szczepieniami. Umieszczono je również w polskim Programie Szczepień Ochronnych.

Szczepienia w ciąży zalecają Polskie Towarzystwo Wakcynologii, Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej.

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej dotyczące szczepień kobiet planujących ciążę, ciężarnych oraz karmiących. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2023;8(2):8: strony 89–103.

Kalendarz szczepień kobiet planujących ciążę i w ciąży

KALENDARZ SZCZEPIEŃ
KOBIET PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ ORAZ KOBIET W CIĄŻY

KALENDARZ SZCZEPIEŃ KOBIET PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ	
SZCZEPIONKA PRZECIW	**OKRES PRZED CIĄŻĄ**
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV)	3 dawki (kobiety, które nie były wcześniej szczepione)
Ospie wietrznej (VZV)*	2 dawki (kobiety, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie były szczepione)
Odrze, śwince, różyczce (MMR)*	1 lub 2 dawki (kobiety, które nie chorowały na różyczkę i nie były szczepione)
Grypie (IIV)	1 dawka na w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu)

KALENDARZ SZCZEPIEŃ KOBIET W CIĄŻY	
SZCZEPIONKA PRZECIW	**OKRES CIĄŻY**
Grypie (IIV)	1 dawka, może być podana w każdym okresie ciąży
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka w każdej ciąży, może być podana między 27. a 36. tygodniem ciąży**
Covid-19	1 dawka (zgodnie z aktualnymi zaleceniami)
Syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV)	1 dawka, może być podana między 24. a 36. tygodniem ciąży (optymalnie między 32. a 36. tygodniem ciąży)

*szczepienie zakończone nie później niż miesiąc przed zajściem w ciążę.
**w uzasadnionych przypadkach zagrożenia przedwczesnym porodem – po ukończeniu 20. tygodnia ciąży.

IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi z obniżoną zawartością składnika błonicy i krztuśca; Covid-19 - szczepionka przeciw Covid-19; RSV - szczepionka przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu; HBV (Hepatitis B Vaccine) - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B; VZV - szczepionka przeciw ospie wietrznej; MMR- szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce

Ministerstwo Zdrowia NPZ
Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Gdzie i jak realizowane są szczepienia dla kobiet w ciąży?

Szczepienia ciężarnej wykonywane są w poradni POZ, po kwalifikacji do szczepienia.

Szczepienie kobiety w ciąży może być wykonane również w aptece, po kwalifikacji do szczepienia.

Link do punktów aptecznych realizujących szczepienia.
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/zaszczep-sie-w-aptece

Szczepienie przeciw	Gdzie?
Grypie	w POZ lub aptece
Krztuścowi	w POZ
RSV	w POZ lub aptece
COVID-19	w aptece lub wybranych POZ

Kto może zakwalifikować kobietę w ciąży do szczepienia?

Przed szczepieniem kobiety w ciąży, podobnie jak przed każdym innym szczepieniem, konieczna jest kwalifikacja do szczepienia.

Kwalifikację do szczepienia kobiety w ciąży może przeprowadzić osoba reprezentująca zawód uprawniony do kwalifikacji do zalecanych szczepień osób dorosłych (lekarz, felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta).

W praktyce, w przypadku ciąży fizjologicznej kwalifikacja do szczepienia kobiety w ciąży prowadzona jest zwykle przez lekarza rodzinnego, pielęgniarkę, położną lub farmaceutę). Szczepienie kobiecie w ciąży zaleca, prowadzący ciążę, ginekolog.

W przypadku ciąży zagrożonej ryzykiem wcześniejszego porodu, pacjentkę kieruje na szczepienie zalecane w POZ – lekarz, który prowadzi ciążę.

W ciąży zagrożonej/powikłanej lub innej sytuacji budzącej wątpliwości lekarza rodzinnego, może być konieczna konsultacja ginekologa położnika w celu wykluczenia przeciwwskazań. Brak lub istnienie przeciwwskazań w takim przypadku powinno zostać udokumentowane wydanym zaświadczeniem.

Szczepienie odnotowane jest w elektronicznej Karcie Szczepień.

Czy kobiecie w ciąży można podać więcej niż jedną szczepionkę w czasie jednej wizyty?

Podanie kobiecie w ciąży więcej niż jednej szczepionki w czasie tej samej wizyty to zalecana praktyka.

Wyniki badań pokazują, iż takie postępowanie nie wiąże się z większym ryzykiem ewentualnych niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jest dla kobiety w ciąży i przebiegu ciąży bezpieczne. Pozwala w prostszy sposób i przy mniejszej liczbie wizyt realizować program szczepień zalecanych w okresie ciąży.

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami amerykańskiego komitetu doradczego ds. szczepień szczepionkę przeciw RSV można podać w dowolnym czasie przed podaniem innych szczepionek zalecanych ciężarnym lub po ich podaniu (tzn. przeciw krztuścowi preparatem Tdap, przeciw grypie i przeciw COVID-19). Dotyczy to również podania z innymi szczepionkami podczas jednej wizyty, tego samego dnia. Brytyjski komitet doradczy ds. szczepień wskazuje, że pacjentce zgłaszającej się w zalecanym okresie ciąży na szczepienie przeciw RSV i która w czasie ciąży nie była jeszcze szczepiona przeciw krztuścowi, wręcz należy obie te szczepionki podać na jednej wizycie. Na podobnym stanowisku generalnie stoi większość innych uznanych krajowych komitetów doradczych ds. szczepień ochronnych.

W przypadku kiedy szczepionki podawane są w czasie oddzielnych wizyt, odstępy pomiędzy nim mogą być dowolne.

Jak finansowane są szczepionki zalecane dla kobiet w ciąży?

W Polsce wszystkie szczepienia zalecane dla kobiet w ciąży są bezpłatne.

Szczepienie przeciw	Jaki preparat?	Sposób finansowania
Grypie	Influvac Tetra lub Vaxigrip Tetra	Recepta na refundowaną szczepionkę („lista C"), wystawiona przez lekarza, położną, pielęgniarkę lub farmaceutę.
Krztuścowi	Adacel lub Boostrix/ BoostrixPolio	Szczepienie w POZ, recepta ani skierowanie są niepotrzebne.
RSV	Abrysvo	Recepta na refundowaną szczepionkę („lista C"), wystawiona przez lekarza, położną, pielęgniarkę lub farmaceutę.
COVID-19	Preparat mRNA, zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia	Szczepienie w punktach realizujących szczepienia przeciw COVID-19, recepta niepotrzebna.

Jak i kiedy mówić o szczepieniach kobiet w ciąży?

We wspólnych zaleceniach Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej wskazano, że położnicy-ginekolodzy, lekarze rodzinni oraz wakcynolodzy powinni informować i edukować kobiety planujące ciążę i będące w ciąży lub karmiące piersią, o zalecanych szczepieniach ochronnych, a także zachęcać do ich wykonywania.

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej dotyczące szczepień kobiet planujących ciążę, ciężarnych oraz karmiących. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2023;8(2):8: strony 89–103.

https://journals.viamedica.pl/ginekologia_polska/article/view/95834



VIA MEDICA

RECOMMENDATIONS

Ginekologia Polska
2023, vol. 94, no. 8, 670–682
Copyright © 2023 PTGiP
ISSN 0017–0011, e-ISSN 2543–6767

DOI 10.5603/gpl.95834

Guidelines of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians, the Polish Society for Vaccinology, and the Polish Society for Family Medicine on vaccinating women with reproductive plans and pregnant or breastfeeding women

Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz[1], Aneta Nitsch-Osuch[2], Krzysztof Czajkowski[3], Krzysztof Drews[1], Hubert Huras[4], Jaroslaw Kalinka[5], Ernest Kuchar[6], Bozena Leszczynska-Gorzelak[7], Agnieszka Mastalerz-Migas[8], Malgorzata Swiatkowska-Freund[9], Miroslaw Wielgos[10], Hubert Wolski[1], Jacek Wysocki[11, 12], Mariusz Zimmer[13], Piotr Sieroszewski[14]

3. SZCZEPIENIE PRZECIW GRYPIE

Dlaczego kobiecie w ciąży zaleca się szczepienie przeciw grypie?

Grypa u kobiet w ciąży występuje częściej niż u innych osób i może przebiegać z zaostrzeniem objawów oraz powikłaniami, co związane jest z koniecznością hospitalizacji.

Ryzyko hospitalizacji ciężarnej z powodu grypy w porównaniu z kobietami niebędącymi w ciąży jest większe:

- 3,5-krotnie u kobiet bez dodatkowych czynników ryzyka,
- 8-krotnie u kobiet z dodatkowymi czynnikami ryzyka,
- 2,5-krotnie większe w I trymestrze ciąży,
- 4-krotnie większe w II trymestrze ciąży,
- 5-krotnie większe w III trymestrze ciąży.

Kobiety w ciąży i połogu, w porównaniu z kobietami niebędącymi w ciąży, częściej wymagały hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii.

Jakie są główne cele szczepienia kobiety w ciąży przeciw grypie?

Ochrona kobiety w ciąży.

Ciąża to czynnik ryzyka ciężkiego przebiegu grypy oraz zgonu z powodu grypy.

Ochrona płodu i przebiegu ciąży.

Grypa stwarza ryzyko śmierci płodu oraz wad wrodzonych płodu.

Ochrona noworodka i niemowlęcia.

Dzieci urodzone przez matki zaszczepione w ciąży rzadziej wymagają hospitalizacji z powodu grypy i jej powikłań.

Kiedy kobieta w ciąży powinna zaszczepić się przeciw grypie?

- W dowolnym trymestrze ciąży, w czasie sezonu epidemicznego grypy.
- Najlepiej przed okresem zwiększonej zachorowalności na grypę, który przypada między styczniem a marcem.

Czas podania szczepionki przeciw grypie kobiecie w ciąży dyktuje sezon grypowy. Najlepiej zaszczepić się przed okresem zwiększonej zachorowalności na grypę, który przypada między styczniem a marcem.

Wrzesień – listopad to ogólnie dobre miesiące na coroczne szczepienie przeciw grypie.

Wczesne szczepienie w lipcu i sierpniu można rozważyć u kobiet, które będą w trzecim trymestrze ciąży, w tym okresie, ponieważ takie postępowanie zmniejszy ryzyko zachorowania u dziecka w pierwszych miesiącach po urodzeniu.

Lekarze zalecają szczepienie kobiet w ciąży przeciw grypie

„W trakcie sezonu epidemicznego grypy, zaleca się zaszczepić kobiety, które są lub będą w ciąży (niezależnie od trymestru), w celu zapobiegania zachorowaniom na grypę i jej powikłaniom oraz zapewnienia biernej ochrony niemowlęcia przed grypą w pierwszych miesiącach ich życia”.

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej dotyczące szczepień kobiet planujących ciążę, ciężarnych oraz karmiących. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2023;8(2):8: strony 89–103.

Podpowiadamy najprostszy i najszybszy sposób szczepienia kobiety w ciąży przeciw grypie.

Szczepionki przeciw grypie dla kobiet w ciąży są bezpłatne.

Dostępne są dwa równorzędne sobie preparaty: Influvac Tetra lub Vaxigrip Tetra.

- Zgłoś się do lekarza POZ, pielęgniarki, położnej, farmaceuty po receptę na refundowaną szczepionkę („lista C”) z zaświadczeniem potwierdzającym ciążę lub kartą ciąży.
- „Kup” (0 zł) szczepionkę w aptece.
- Zgłoś się na szczepienie w POZ lub aptece, która realizuje szczepienia, gdzie po badaniu kwalifikacyjnym zostaniesz bezpłatnie zaszczepiona.

Jak skuteczne jest szczepienie przeciw grypie w ciąży?

Niemowlęta urodzone przez matki zaszczepione przeciw grypie w ciąży mają o:

- 70% niższe ryzyko zachorowania na grypę,
- 80% niższe ryzyko hospitalizacji z powodu grypy.

Czy szczepienie przeciw grypie w ciąży jest bezpieczne?

Szczepienie kobiety w ciąży przeciw grypie jest bezpieczne zarówno dla ciężarnej jak i dla płodu. Realizowane przez ostatnie lata szczepienia kobiet w ciąży, gdzie podano miliony dawek szczepionki, pokazują, że szczepienia te są bezpieczne i skuteczne.

Skąd wiemy, że szczepienie w ciąży jest bezpieczne?

W ostatnich latach zgromadzono wiele danych dotyczących szczepień kobiet w ciąży przeciw grypie.

Dane te pochodzą z badań obserwacyjnych prowadzonych po podaniu szczepionek w ramach kampanii szczepień, retrospektywnej oceny baz danych oraz z raportów z nadzoru nad monitorowaniem niepożądanych odczynów poszczepiennych.

- Badania obserwacyjne w Stanach Zjednoczonych, 1990-2009, ponad 11,8 tys. zaszczepionych kobiet w ciąży. Wyniki raportowania NOP po szczepieniu w systemie VAERS (*Vaccine Adverse Event Reporting System*) pokazały występowanie działań łagodnych.
- Badanie bezpieczeństwa w grupie 9 000 kobiet w ciąży nie wykazało związku między zaszczepieniem przyszłej matki w I trymestrze ciąży, a występowaniem wad rozwojowych u dziecka, natomiast obserwowano mniej martwych urodzeń. Badania wykluczyły związek między szczepieniem przeciw grypie w okresie ciąży a poronieniem.

- W 2012 r. eksperci Komitetu WHO GACVS przedstawili stanowisko na temat bezpieczeństwa szczepień przeciw grypie u kobiet w ciąży, podkreślając bezpieczeństwo stosowania szczepionek pandemicznych A(H1N1)pdm09 podawanych w okresie 2009-2010 kobietom w ciąży w II i III trymestrze.
- W badaniu kohortowym przeprowadzonym w Europie w grupie 2295 kobiet w ciąży, którym podano szczepionkę pandemiczną przeciw grypie A(H1N1)pdm09 z adiuwantem MF59 nie wykazano różnic w przebiegu ciąży, w porównaniu z kobietami niezaszczepionymi oraz mniej przedwczesnych urodzeń.
- W wieloośrodkowym badaniu w Argentynie w grupie 7293 kobiet w ciąży zaszczepionych szczepionką pandemiczną przeciw grypie A(H1N1)pdm09 z adiuwantem MF59 nie wykazano niekorzystnego wpływu na przebieg ciąży.
- Wyniki badań z Danii prowadzone w grupie 7000 kobiet w ciąży zaszczepionych szczepionką pandemiczną przeciw grypie A(H1N1) pdm09 z adiuwantem AS03 nie wykazały związku między szczepieniem a poronieniem, porodem przedwczesnym, wystąpieniem wad wrodzonych płodu lub zahamowaniem wzrostu płodu.
- Wyniki badań z Wielkiej Brytanii w grupie 9445 kobiet zaszczepionych szczepionką pandemiczną przeciw grypie A(H1N1)pdm09 z adiuwantem AS03 nie wykazały zwiększonego ryzyka poronienia w porównaniu z grupą kontrolną obejmującą 30 218 niezaszczepionych kobiet w ciąży.
- Badania przeprowadzone w Szwecji w grupie 18 612 kobiet w ciąży zaszczepionych szczepionką pandemiczną przeciw grypie A(H1N1)pdm09 z adiuwantem AS03 wykazały, że ryzyko urodzenia martwego dziecka, przedwczesnego porodu oraz niskiej masy urodzeniowej było mniejsze w grupie kobiet zaszczepionych w porównaniu do grupy kontrolnej.
- W badaniach kanadyjskich oceniano związek między szczepieniem przeciw grypie pandemicznej H1N1 w 2009 r. kobiety w ciąży, a wynikami zdrowotnymi u dzieci (urodzonych od listopada 2009 r. do

października 2010 r.), w ciągu pierwszych pięciu lat ich życia. Wśród 104 249 dzieci urodzonych w tym czasie, 31 315 (30%) to były dzieci, których matki zaszczepiono w ciąży przeciw grypie. Nie stwierdzono występowania podwyższonego ryzyka raka, zakażeń, chorób przewlekłych, przyjęć do szpitala lub zgonów dzieci matek szczepionych w okresie ciąży.

- Dane z australijskiego czynnego systemu nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi zwanego AusVaxsSafety również potwierdzają bezpieczeństwo szczepień kobiet w ciąży przeciw grypie. W grupie 3 188 kobiet w ciąży zaszczepionych przeciw grypie w okresie od 1 kwietnia do 7 lipca 2019 r. uzyskano następujące wyniki: 94,7% nie zgłosiło żadnych odczynów niepożądanych, 5,3% zgłosiło odczyny niepożądane pod postacią: 2,1% reakcji w miejscu wkłucia, 0,8% gorączki, 0,2% wysypki.
- Badanie z 2013 roku: w sezonach grypowych 2010–2011 oraz 2011–2012 szczepienie przeciw grypie sezonowej zmniejszyło ryzyko zachorowania na grypę wśród kobiet w ciąży o 50%.
- Badanie z 2018 roku: szczepienie przeciw grypie zmniejszyło ryzyko hospitalizacji z powodu grypy u kobiet w ciąży średnio o 40%.

4. SZCZEPIENIE PRZECIW KRZTUŚCOWI

Dlaczego kobiecie w ciąży zaleca się szczepienie przeciw krztuścowi?

Zachorowanie na krztusiec jest realne. Krztusiec jest ciężką chorobą zakaźną. Cechuje się wysoką zakaźnością. W ostatnim czasie obserwujemy wzrost zachorowań na krztusiec w Polsce.

Krztusiec może być dla niemowląt niebezpieczny. Krztusiec jest ostrą chorobą dróg oddechowych, głównie wieku dziecięcego, wywoływaną przez bakterie *Bordetella pertussis*. Choroba jest szczególnie niebezpieczna dla noworodków i niemowląt w pierwszych 6 miesiącach życia. Charakterystycznym objawem choroby jest długotrwale utrzymujący się napadowy kaszel z wydzielaniem lepkiej plwociny. Najcięższy przebieg krztuśca u niemowląt przebiega z krztuszeniem, łapaniem powietrza, bradykardią, bezdechem. Mogą występować powikłania: zapalenia płuc, nadciśnienie płucne, krwotoki dospojówkowe, przepuklina, drgawki, encefalopatia. Choroba może być zagrożeniem życia. Śmiertelność szacowana jest na 1% wśród niemowląt <2 m.ż. i 0,5% wśród niemowląt w 2-11.m.ż.

Niemowlęta nie mają odporności przeciw krztuścowi. Niemowlęta w pierwszych miesiącach życia nie mają jeszcze w pełni ukształtowanego układu odporności, nie zostały jeszcze w pełni zaszczepione i nie mają własnej odporności przeciw krztuścowi.

Bierna ochrona niemowlęcia. Szczepienie przeciw krztuścowi kobiety w III trymestrze ciąży powoduje, że wytwarza ona swoiste przeciwciała, które przechodzą przez łożysko do płodu. Dzięki temu dziecko po urodzeniu ma „gotowe przeciwciała", które zapewniają mu ochronę przed krztuścem w pierwszych 3-6 miesiącach życia.

Jakie są główne cele szczepienia przeciw krztuścowi w okresie ciąży?

Ochrona noworodka i niemowlęcia.

Głównym celem szczepienia kobiety w ciąży przeciw krztuścowi jest ochrona noworodków i niemowląt w pierwszych 3-6 miesiącach życia przed zachorowaniem, hospitalizacją i zgonem z powodu krztuśca.

Ochrona kobiety w ciąży.

Korzyści ze szczepienia w postaci wzmocnienia odporności odnosi również zaszczepiona kobieta. Krztusiec w postaci silnego kaszlu może być uciążliwy dla kobiety w ciąży. Szczepienie chroni kobietę przed zachorowaniem, dzięki czemu nie przenosi ona zakażenia na dziecko.

Jak działa szczepionka przeciw krztuścowi podana kobiecie w ciąży?

Po szczepieniu matka wytwarza swoiste przeciwciała ochronne, które przechodzą przez łożysko i chronią dziecko w pierwszych miesiącach jego życia, kiedy jest najbardziej narażone na zachorowanie, bo nie ma jeszcze swojej odporności.

Szczepienia dzieci przeciw krztuścowi zaczynają się w 2 miesiącu życia. Dla wytworzenia pełnej odporności potrzebne są kolejne dawki szczepionki, więc do tego czasu dziecko jest nieuodpornione. Ochrona dzieci poprzez szczepienie ciężarnych wynika z transferu przez łożysko do płodu

przeciwciał przeciw bakteriom *Bordetella pertussis*, wytworzonych w organizmie matki w odpowiedzi na antygeny zawarte w szczepionce. Tak więc szczepienie mamy w okresie ciąży ochroni dziecko do czasu wytworzenia przez nie własnej odporności związanej z jego szczepieniami.

Jaka jest skuteczność szczepienia kobiet w ciąży przeciw krztuścowi?

- Szczepienie cechuje się wysoką skutecznością.
- Duże populacyjne badanie kohortowe z Australii (279 tys. par matka-niemowlę):
- 52% otrzymało szczepionkę Tdap ≥14 dni przed porodem.
- U dzieci matek zaszczepionych:
- 61,5% mniej zachorowań na krztusiec w pierwszych 6. miesiącach życia
- 60,2% mniej zachorowań na krztusiec wymagających hospitalizacji.
- Szczepienie przeciw krztuścowi szczepionka Tdap znacząco zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu krztuśca u niemowląt.
- Skuteczność szczepienia jest najwyższa u niemowląt w pierwszych 3-6 miesiącach po urodzeniu.

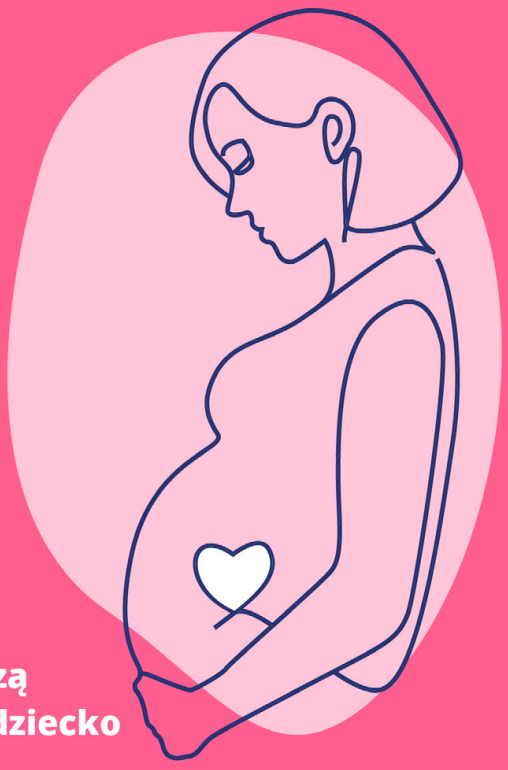
Lekarze zalecają szczepienie kobiety w ciąży przeciw krztuścowi

„Szczepienie przeciw krztuścowi szczepionką Tdap przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi ze zmniejszoną zawartością składników błonicy i krztuśca, zalecane jest dla kobiet planujących ciążę, ciężarnych oraz karmiących”.

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej dotyczące szczepień kobiet planujących ciążę, ciężarnych oraz karmiących. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2023;8(2):8: strony 89–103.

szczepienia info

Szczepienie przeciw krztuścowi kobiety w ciąży



CEL

Ochrona noworodka i niemowlęcia w pierwszych 3-6 miesiącach życia.

KIEDY

III trymestr ciąży (między 27 a 36 t.c.)*

JAK

Swoiste przeciwciała po zaszczepieniu matki przechodzą przez łożysko do płodu i chronią dziecko po urodzeniu.

** w uzasadnionych przypadkach zagrożenia przedwczesnym porodem – po ukończeniu 20. tygodnia ciąży.*

Ministerstwo Zdrowia NPZ

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Gdzie kobieta w ciąży może zaszczepić się przeciw krztuścowi?

Kobieta w ciąży może zaszczepić się przeciw krztuścowi w swojej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), w ramach złożonej deklaracji do lekarza POZ.

Szczepienie jest bezpłatne. Szczepionkę udostępnia POZ.

Pacjentka nie potrzebuje recepty na szczepionkę ani skierowania.

Kwalifikację do szczepienia kobiety w ciąży prowadzi lekarz POZ. Dodatkowo, w przypadku ciąży zagrożonej ryzykiem wcześniejszego porodu, pacjentkę kieruje na szczepienie zalecane w POZ lekarz, który prowadzi ciążę.

Jaką szczepionką realizowane jest szczepienie kobiety ciąży przeciw krztuścowi?

Jako szczepienie przeciw krztuścowi kobiecie w ciąży podawana jest szczepionka Tdap przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi z obniżoną zawartością składników błonicy i krztuśca lub ich pochodne ze składnikiem polio (Tdap-polio).

Nazwy handlowe szczepionek: Adacel lub Boostrix/BoostrixPolio.

Kiedy zalecane jest szczepienie kobiety w ciąży przeciw krztuścowi?

Szczepienie jest zalecane:

- kobietom w ciąży po ukończeniu 27. do 36. tyg. ciąży,
- kobietom w ciąży zagrożonej przedwczesnym porodem, po ukończeniu 20. tyg. ciąży.

Szczepionka przeciw krztuścowi powinna być podawana w każdej ciąży, niezależnie od wcześniejszych szczepień.

W jakich krajach poza Polską realizowane są szczepienia kobiet w ciąży przeciw krztuścowi?

W ciągu ostatnich 10 lat zalecenie szczepień przeciw krztuścowi kobiet w ciąży wprowadzono w wielu krajach. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych program szczepień przeciw krztuścowi kobiet w ciąży jest realizowany od 2011 roku. W Wielkiej Brytanii szczepienie ciężarnych przeciw krztuścowi wprowadzono interwencyjnie w 2012 roku w odpowiedzi na wysoką zapadalność na krztusiec u młodszych niemowląt, a od 2019 roku wykonuje się je rutynowo w ramach krajowego programu szczepień ochronnych. Program szczepień przeciw krztuścowi kobiet w ciąży prowadzony jest również w Irlandii, Belgii, Czechach, Grecji, Włoszech, Portugalii, Szwajcarii, Nowej Zelandii, Australii.

Czy szczepienie kobiety w ciąży przeciw krztuścowi jest bezpieczne?

Wyniki badań potwierdzają bezpieczeństwo szczepień kobiet w ciąży przeciw krztuścowi.

Szczepienie przeciw krztuścowi kobiet w III trymestrze ciąży jest bezpieczne i nie zwiększa ryzyka niekorzystnych następstw tak u matki jak i u jej dziecka.

Jakie badania potwierdzają bezpieczeństwo szczepień przeciw krztuścowi u kobiet w ciąży?

W ostatnich latach zgromadzono wiele danych dotyczących szczepień kobiet w ciąży przeciw krztuścowi.

Dane te pochodzą z badań obserwacyjnych prowadzonych po podaniu szczepionek w ramach kampanii szczepień, retrospektywnej oceny baz danych oraz z raportów z nadzoru nad monitorowaniem niepożądanych odczynów poszczepiennych.

- Bezpieczeństwo szczepionki Tdap podawanej kobietom w ciąży potwierdziła analiza wyników z bazy danych VAERS w okresie 2005-2010, gdzie wśród 106 573 raportów 132 dotyczyły kobiet ciężarnych.
- Wśród monitorowanych prawie 30 000 kobiet ciężarnych w Stanach Zjednoczonych w okresie 2007-2013 nie zaobserwowano częstszego występowania NOP, tj. gorączki, alergii, niskiej masy urodzeniowej ciała, wcześniactwa w odniesieniu do grupy porównawczej, w której kobiety zaszczepiono ponad 5 lat wcześniej (*Sukumaran* i wsp. *2014*).
- W amerykańskim badaniu kohortowym z retrospektywnym zbieraniem danych w okresie 2005-2009 oceniono wpływ szczepień na przebieg ciąży i zdrowie noworodków w grupie 162 448 kobiet w ciąży, z których 138 zaszczepiono szczepionką dTap. Wśród szczepionych w porównaniu z grupą kontrolną niezaszczepionych kobiet ciężarnych nie stwierdzono zwiększonego odsetka poronień, martwych urodzeń ani przedwczesnych porodów.
- Bezpieczeństwo szczepionki dTap u kobiet w ciąży oceniono również w badaniu obserwacyjnym z retrospektywnym zbieraniem danych w stanie Teksas, w grupie 1759 kobiet, które w latach 2012–2014 urodziły dziecko, w tym 1109 kobiet zaszczepionych dTap i 650 niezaszczepionych. Wyniki nie wykazały istotnych różnic między kobietami zaszczepionymi Tdap a kobietami nieszczepionymi w czasie ciąży, poza rzadszym wykonywaniem cesarskiego cięcia w grupie kobiet zaszczepionych.
- W badaniu obserwacyjnym w czasie kampanii szczepień w Wielkiej Brytanii w 2012 r., w grupie 20 074 kobiet w ciąży zaszczepionych w III trymestrze, w porównaniu z grupą kontrolną nie obserwowano zwiększonej liczby poronień i innych niekorzystnych zdarzeń, które mogą wystąpić w czasie naturalnej ciąży.
- W badaniu kohortowym prowadzonym w Wielkiej Brytanii, które obejmowało 6 185 kobiet w ciąży zaszczepionych w 33 tyg. w porównaniu z grupą kontrolną (18 496 niezaszczepionych kobiet), nie stwierdzono zwiększonego ryzyka wewnątrzmacicznego zgonu płodu w okresie od 14 dnia od wykonania szczepienia do ukończenia

24 tyg. ciąży, ani innych niekorzystnych zdarzeń położniczych i neonatologicznych (tj. upośledzenia wzrastania wewnątrzmacicznego lub urodzenia dziecka o masie <2500 g, stanu przedrzucawkowego lub rzucawki, łożyska przodującego, cesarskiego cięcia, porodu przedwczesnego, krwawienia po porodzie).

- Wyniki z australijskiego czynnego systemu nadzoru nad NOP w ramach systemu AusVaxSafety wskazują, że w grupie 5 085 kobiet w ciąży zaszczepionych przeciw krztuścowi szczepionką dTap w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. – 94% nie zgłosiło żadnych odczynów niepożądanych, 6% zgłosiło odczyny niepożądane pod postacią: 0,8% gorączki, 2,4% bólu w miejscu wkłucia, 1,7% obrzęku/zaczerwienienia w miejscu wkłucia, 0,1 % wysypki.

5. SZCZEPIENIE PRZECIW RSV

Dlaczego kobiecie w ciąży zaleca się szczepienie przeciw RSV?

RSV czyli syncytialny wirus oddechowy jest jedną z głównych przyczyn ostrych infekcji dróg oddechowych u małych dzieci. Szczególnie narażone są dzieci w 1. roku życia (zakażenie dotyczy 60-70% dzieci, a 2-3% zakażenie wymaga hospitalizacji). Wirus jest czterokrotnie bardziej zaraźliwy od wirusa grypy. Przenosi się drogą kropelkową. Wirus jest szczególnie niebezpieczny dla nieukształtowanego jeszcze lub osłabionego układu odpornościowego noworodka i niemowlęcia. Często tacy pacjenci trafiają do szpitala. Niemowlaki mogą mieć duże duszności, kłopoty z oddychaniem. Wymagają wspierania tlenem. Infekcję leczy się objawowo, nie ma leków na tę konkretną chorobę. Powoduje infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych. Powikłaniem może być zapalenie oskrzelików i zapalenie płuc. Wywołuje objawy zbliżone do grypowych, to częściej występują tutaj duszność i świszczący oddech. Występują również katar, kaszel, ból gardła. Po przebyciu infekcji RSV nie nabywa się odporności. Można zachorować kilka razy.

Zachorowania na RSV w Polsce wzrastają w okresie listopad–marzec, a ich szczyt przypada na grudzień–luty. Przez blisko osiem miesięcy 2025 r. roku (1.01.2025-15.08.2025) potwierdzono 7,1 tys. przypadków grypy oraz 92 tys. zakażeń wirusem RSV, z czego 33 tys. to zakażenia u dzieci poniżej 2 lat.

Jakie są główne cele szczepienia kobiety w ciąży przeciw RSV?

Ochrona noworodka i niemowlęcia. Szczepienie jest skuteczną strategią zapobiegania chorobie dolnych dróg oddechowych związanej z RSV, wymagającej hospitalizacji u niemowląt od urodzenia do pierwszych 6 miesięcy życia.

Zaszczepienie kobiety w ostatnim trymestrze ciąży zapewnia przezłożyskowy transport przeciwciał neutralizujących do organizmu dziecka, dzięki czemu w pierwszych 6 miesiącach życia jest ono chronione przed RSV.

Zaszczepienie matki buduje odporność nowo narodzonego dziecka. Chroni to przed ciężkim przebiegiem choroby i powikłaniami co wymaga hospitalizacji, wizytami na OIOM i zgonami.



Ministerstwo Zdrowia
NPZ
Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Jaką szczepionką realizowane jest szczepienie kobiety ciąży przeciw RSV?

Szczepienie kobiet w ciąży przeciw RSV realizowane jest szczepionką biwalentną, rekombinowaną o nazwie Abrysvo.

Szczepionka objęta jest refundacją aptieczną. Bezpłatna dla kobiet w ciąży na podstawie recepty z kodem C.

Kiedy kobieta w ciąży powinna zaszczepić się przeciw RSV?

Szczepienie zaleca się kobietom w okresie od 24. tyg. ciąży do 36. tyg. ciąży.

Eksperci towarzystw naukowych zalecają wykonanie tego szczepienia optymalnie pomiędzy 32. tyg. ciąży a 36. tyg. ciąży, aby uzyskać jak najwyższe korzyści ze szczepienia oraz z powodu najlepiej poznanego profilu bezpieczeństwa szczepionki.

Szczepionkę przeciw RSV w okresie ciąży zaleca się podać optymalnie 1-2 miesiące przed rozpoczęciem sezonu infekcyjnego RSV i do 2-3 miesięcy przed przewidywanym zakończeniem sezonu. Sezon epidemiczny RSV utrzymuje się zwykle od października lub listopada do kwietnia lub maja.

Lekarze zalecają szczepienie kobiety w ciąży przeciw RSV

Rekomendacje szczepień przeciw RSV są wskazane w polskim Programie Szczepień Ochronnych.

Szczepienie przeciw RSV kobietom w ciąży zaleca Polskie Towarzystwo Wakcynologii *„Rekomendacje dotyczące profilaktyki biernej zakażenia syncytialnym wirusem oddechowym (RSV) w populacji niemowląt w sezonie 2024/2025”. Pediatria po Dyplomie. 4/2024.*

Obecnie ponad 50 krajów/regionów zaleca szczepienie kobiet w ciąży przeciw RSV.

Podpowiadamy najprostszy i najszybszy sposób szczepienia kobiety w ciąży przeciw RSV.

Szczepienie kobiety w ciąży przeciw RSV można zrealizować w POZ. Potrzebna jest recepta na refundowaną szczepionkę. Szczepionkę „kupuje się" (0 zł) w aptece.

Szczepienie kobiety w ciąży może być wykonane również w aptece.

Link do punktów aptecznych realizujących szczepienia.
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/zaszczep-sie-w-aptece

Jaka jest skuteczność szczepienia kobiety w ciąży przeciw RSV?

Szczepienie kobiety w ciąży przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV) jest skuteczną strategią zapobiegania chorobie dolnych dróg oddechowych związanej z RSV wymagającej hospitalizacji u niemowląt od urodzenia do pierwszych 6 miesięcy życia.

W badaniu klinicznym szczepionka pzreciw RSV podawana w okresie ciąży zmniejszyła:

- ryzyko hospitalizacji dziecka z powodu RSV o 68% oraz ryzyko wizyty zdrowotnej związanej z RSV o 57% w ciągu 3 miesięcy po urodzeniu.
- ryzyko hospitalizacji dziecka z powodu RSV o 57% oraz ryzyko wizyty zdrowotnej związanej z RSV o 51% w ciągu 6 miesięcy po urodzeniu,
- ryzyko poważnych powikłań u niemowląt spowodowanych przez RSV, w tym niedotlenienia krwi, konieczności wentylacji mechanicznej lub przyjęcia na oddział intensywnej terapii, o 82% w ciągu 3 miesięcy i o 69% w ciągu 6 miesięcy po urodzeniu.

Czy szczepienie kobiety w ciąży przeciw RSV jest bezpieczne?

Szczepienie kobiety w ciąży przeciw RSV jest bezpieczne zarówno dla ciężarnej jak i dla płodu.

6. Szczepienie przeciw COVID-19

Dlaczego kobiecie w ciąży zaleca się szczepienie przeciw COVID-19?

COVID-19 może być niebezpieczny w okresie ciąży. Zakażenie COVID-19 w ciąży wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby u matki, przyjęcia na oddział intensywnej terapii, wentylacji mechanicznej oraz zgonu.

Stanowi zagrożenie dla płodu. Zakażenie COVID-19 zwiększa ryzyko przedwczesnego porodu, a także może zwiększać ryzyko martwego urodzenia.

Niemowlęta nie mają odporności przeciw COVID-19. Kobiety w ciąży, które otrzymują szczepienie przeciw COVID19, pomagają chronić swoje dziecko przed zachorowaniem, kiedy one same nie ma jeszcze w pełni ukształtowanego układu odporności i jest za małe, aby mogło być zaszczepione.



Jakie są główne cele szczepienia kobiety w ciąży przeciw COVID-19?

Ochrona noworodka i niemowlęcia.

Szczepienie przeciw COVID-19 kobiety w ciąży chroni niemowlę przed zachorowaniem w pierwszych 6 miesiącach życia.

Ochrona kobiety w ciąży.

Szczepienie zmniejsza ryzyko zachorowania, ciężkiego przebiegu choroby i powikłań wpływających na przebieg ciąży.

Kiedy kobieta w ciąży powinna zaszczepić się przeciw COVID-19?

Szczepienie przeciw COVID-19 zaleca się wykonać preparatem mRNA dostosowanym do aktualnie krążącego wariantu SARS-CoV-2 w danym sezonie infekcyjnym. Szczepienie można wykonać w dowolnym trymestrze ciąży. Jego przeprowadzenie w II lub III trymestrze może dodatkowo wzmocnić bierną ochronę niemowlęciu w pierwszych 6 m.ż. Szczepionka jest bezpłatna. Recepta na szczepionkę jest niepotrzebna. Szczepienie prowadzone jest zgodnie z komunikatami Ministerstwa Zdrowia w punktach szczepień realizujących szczepienia przeciw COVID-19.

Lekarze zalecają szczepienie kobiety w ciąży przeciw COVID-19

Amerykańskie Towarzystwo Położników i Ginekologów (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG).

Komunikaty Ministra Zdrowia w sprawie realizacji szczepień przeciw COVID-19.

https://pacjent.gov.pl/szczepienie-przeciw-covid-19

Podpowiadamy najprostszy i najszybszy sposób szczepienia kobiety w ciąży przeciw COVID-19.

Szczepionki przeciw COVID-19 dla kobiet w ciąży są bezpłatne.

Szczepienie można zrealizować w aptece prowadzącej szczepienia lub POZ.

Link do punktów aptecznych realizujących szczepienia.

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/zaszczep-sie-w-aptece

Skierowanie ani recepta są niepotrzebne.

Jak skuteczne jest szczepienie przeciw COVID-19 w ciąży?

Skuteczność szczepionek przeciw COVID-19 jest podobna u kobiet w ciąży i osób niebędących w ciąży w podobnym wieku w zapobieganiu zakażeniom i hospitalizacjom.

Nawet jeśli pacjentka zachoruje po szczepieniu, ryzyko ciężkiego przebiegu choroby jest bardzo niskie.

Większość hospitalizowanych pacjentów to osoby, które nie otrzymały szczepionki przeciw COVID-19.

Czy szczepienie przeciw COVID-19 w ciąży jest bezpieczne?

Szczepienie kobiety w ciąży przeciw COVID-19 jest bezpieczne zarówno dla ciężarnej jak i dla płodu.

Skąd wiemy, że szczepienie kobiety w ciąży przeciw COVID-19 jest bezpieczne?

Wyjściowe badania kliniczne szczepionek przeciw COVID-19 nie obejmowały kobiet w ciąży. Należy jednak zaznaczyć, że niektóre uczestniczki badań klinicznych zaszły w ciążę po zapisaniu się do udziału w badaniu i nie zgłoszono z ich strony żadnych powikłań po szczepieniu. Ponadto wytwórcy szczepionek prowadzili badania laboratoryjne na zwierzętach (ciężarnych szczurach), w których nie wykazano występowania skutków ubocznych po szczepieniu.

Od czasu opracowania i rejestracji szczepionek przeciw COVID-19 liczne badania oceny bezpieczeństwa i skuteczności rzeczywistej prowadzone w różnych populacjach potwierdziły, że szczepionka przeciw COVID-19 jest bezpieczna i skuteczna dla kobiet w ciąży.

- Metaanaliza z 2024 r. obejmująca 1,8 miliona zaszczepionych kobiet w ciąży nie wykazała zwiększonego ryzyka złych wyników dla kobiety w ciąży, płodu lub niemowlęcia i wykazała, że szczepienie dowolną szczepionką przeciw COVID-19 zmniejszyło ryzyko hospitalizacji o 94%.
- Badanie z 2021 r. w którym wzięło udział 35 000 zaszczepionych kobiet w ciąży, nie wykazało wzrostu niekorzystnych wyników ciąży ani wpływu na zdrowie noworodków.
- Badanie z 2022 r. wykazało, że niemowlęta, których matki zostały zaszczepione w czasie ciąży, miały o 61% niższe ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19.
- Wyniki oceny bezpieczeństwa szczepionek przeciw COVID-19 (system V-safe i VAERS) podawanych kobietom w ciąży w ramach programu szczepień w Stanach Zjednoczonych nie wykazały żadnych niepokojących sygnałów bezpieczeństwa wśród zaszczepionych kobiet w ciąży oraz niemowląt w pierwszych 6 miesiącach życia.
- Dane oceny skuteczności szczepionek przeciw COVID-19 podawanych kobietom w ciąży w ramach programu szczepień pokazują, że niemowlęta urodzone przez matki zaszczepione w czasie ciąży miały o 47-56% niższe ryzyko zachorowania na COVID-19.
- Z metaanalizy 29 badań z 8 krajów, gdzie oceniano bezpieczeństwo szczepień przeciw COVID-19 kobiet w ciąży (łącznie 334 210 kobiet) wynika, że w populacjach zaszczepionych obserwowano: mniejsze ryzyko urodzenia martwego dziecka, brak zwiększonego ryzyka poronienia, brak zwiększonego ryzyka przedwczesnego porodu, brak zwiększonego ryzyka niskiej masy urodzeniowej, brak zwiększonego ryzyka wad wrodzonych, brak zwiększonego ryzyka przyjęcia na OIOM, brak problemów zdrowotnych u dzieci do 6 m.ż.

7. Więcej odpowiedzi na pytania dotyczące szczepień kobiet w ciąży

Jakich szczepionek nie można podawać w czasie ciąży?

Okres ciąży jest przeciwwskazaniem do podawania szczepionek żywych, tj. MMR przeciw odrze, śwince, różyczce oraz przeciw ospie wietrznej, ze względu na teoretyczne ryzyko przeniesienia drobnoustroju szczepionkowego na płód. Kobieta po szczepieniu żywą szczepionką (np. przeciw odrze, śwince i różyczce lub ospie wietrznej) nie powinna zachodzić w ciążę przez okres co najmniej 1 miesiąca.

Czy możliwe jest przeniesienie szczepionkowego wirusa ospy wietrznej od osoby zaszczepionej na osobę z bliskiego otoczenia?

Szczepionka przeciw ospie wietrznej zawiera żywego, osłabionego wirusa ospy wietrznej. Jednak możliwość przeniesienia wirusa pochodzącego ze szczepionki na osoby blisko kontaktujące się z zaszczepionym dzieckiem jest wyłącznie teoretyczna. Po szczepieniu bardzo rzadko, u ok. 5-6% zaszczepionych mogą wystąpić objawy niepożądane w postaci wysypki plamistej (niezwykle rzadko ta wysypka przyjmuje postać pęcherzyków ospowych z płynem surowiczym), ale nawet wtedy zakażenie się wirusem ospy wietrznej jest czysto teoretyczne. Nie należy mylić zakażenia od chorego na ospę, który zakaził się wirusem, który krąży w środowisku od sytuacji wyżej opisanej (bardzo rzadkiej), kiedy wystąpi wysypka po szczepieniu, wtedy możliwość przeniesienia zakażenia jest trudna do stwierdzenia ze względu na brak danych.

- Ryzyko przeniesienia wirusa szczepionkowego od osób szczepionych u których wystąpiła wysypka pęcherzykowa, na osoby z prawidłową i obniżoną odpornością jest niezwykle rzadkie: na 16 milionów dawek opisano 3 takie przypadki. Jeżeli u osoby zaszczepionej po szczepieniu pojawiłyby się pęcherzykowe wykwity ospowe należy zapobiegawczo zachować ostrożność i ograniczyć jej kontakt z osobą z obniżoną odpornością. Podobnie można szczepić dzieci, których matki są w ciąży. Nie ma udokumentowanego ryzyka przeniesienia zakażenia na matkę od zaszczepionego dziecka.
- Zgodnie z zaleceniami można szczepić dzieci kobiet będących w ciąży, a także otoczenie osób z niedoborami odporności.

Co ma zrobić kobieta w ciąży, która miała kontakt z osobą chorą na różyczkę, a nie była szczepiona przeciw tej chorobie, ani na nią nie chorowała?

- Zakażenie wirusem różyczki można przejść bezobjawowo. W trybie pilnym należy wykonać badanie krwi na obecność przeciwciał przeciw wirusowi różyczki. Wykrycie przeciwciał w klasie IgG świadczy o przebytej różyczce.
- Jeśli kobieta jest w II lub III trymestrze ciąży, nie ma zagrożenia dla dziecka. Natomiast w I trymestrze takie zagrożenie istnieje (im wcześniejsza ciąża, tym większe ryzyko), dlatego w przypadku nie wykrycia przeciwciał przeciw wirusowi różyczki, zaleca się podanie immunoglobuliny.

Czy w czasie karmienia piersią można podawać szczepionki?

- W czasie karmienia piersią można podawać szczepionki zalecane osobom dorosłym.
- Karmienie piersią nie jest przeciwwskazaniem do podania dostępnych i stosowanych szczepionek dla dorosłych.

W okresie karmienia piersią można podawać wszystkie szczepionki inaktywowane (zabite) oraz szczepionki żywe, zalecane do podawania dla osób dorosłych, których nie podano przed okresem ciąży lub w czasie ciąży.

Członków rodziny kobiety w ciąży można szczepić szczepionką MMR przeciw odrze, śwince i różyczce, ponieważ żywe, osłabione wirusy zawarte w tej szczepionce nie przenoszą się z osoby szczepionej na innych. Podobnie można szczepić dzieci, których matki są w ciąży przeciw ospie wietrznej. Nie znamy dowodów występowania ryzyka przeniesienia zakażenia na matkę od zaszczepionego dziecka.

8. Jak rozmawiać z pracownikiem medycznym o szczepieniach w okresie ciąży?



Rozmowa z pracownikiem medycznym o szczepieniach w okresie ciąży daje możliwość uporządkowania wiedzy, wyjaśnienia obaw, osadzenia decyzji w faktach, a nie w emocjach czy narracjach z Internetu. Aby ta rozmowa była klarowna i naprawdę pomocna, warto dobrze się do niej przygotować – zarówno pod względem merytorycznym, jak i emocjonalnym.

Poniżej znajduje się dwadzieścia rozbudowanych wskazówek, które pomogą Ci w pełni wykorzystać wizytę i uzyskać informacje potrzebne do spokojnego podjęcia decyzji o szczepieniach.

1. Zastanów się, o jakich kwestiach chcesz rozmawiać i co jest dla Ciebie najważniejsze

Przed wizytą poświęć chwilę, aby określić, czego tak naprawdę oczekujesz od rozmowy. Szczepienia w ciąży są tematem wielowymiarowym: dotyczą bezpieczeństwa Twojego dziecka, Twojego zdrowia, aktualnych zaleceń i tego, co jest najlepsze w danym trymestrze. Warto więc ustalić, czy chcesz uzyskać ogólną wiedzę na temat szczepień zalecanych w ciąży, czy interesuje Cię konkretna szczepionka, czy może chcesz rozwiać obawy wynikające z informacji przeczytanych w Internecie. Jasno określony cel sprawia, że rozmowa z pracownikiem medycznym staje się bardziej uporządkowana i pomocna.

2. Przygotuj informacje o swoim stanie zdrowia, ponieważ od tego zależy kwalifikacja do szczepienia

Dla pracownika medycznego ocena możliwości wykonania szczepienia w ciąży wymaga znajomości kilku istotnych elementów. Warto więc przygotować informacje dotyczące chorób przewlekłych, alergii, przyjmowanych leków, przebiegu poprzednich ciąż czy ewentualnych komplikacji. Pomyśl również o ostatnich infekcjach lub objawach, które mogłyby mieć znaczenie przy kwalifikacji. Spisanie tych informacji na kartce lub w telefonie sprawia, że niczego nie pomijasz, a pracownik medyczny może szybciej ocenić sytuację i dopasować zalecenie do Twojego zdrowia oraz etapu ciąży.

3. Zapisz wszystkie pytania i wątpliwości – szczególnie te związane z bezpieczeństwem dziecka

Naturalne jest to, że w ciąży pojawiają się pytania dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, ich działania na organizm matki i wpływu na rozwijające się dziecko. Wiele kobiet po wizycie przypomina sobie, że zapomniały o czymś ważnym, dlatego przygotowanie listy pytań pomaga przeprowadzić rozmowę w sposób spokojny, uporządkowany i pełny. Pytania mogą dotyczyć zarówno mechanizmu działania szczepionki, jak i tego, dlaczego jest zalecana właśnie w konkretnym trymestrze. Nie ma pytań „głupich" – wszystkie są zasadne, jeśli dotyczą Twojego zdrowia i zdrowia dziecka.

4. Jeśli korzystałaś z informacji z Internetu, mediów społecznościowych lub od bliskich, powiedz o tym wprost

W ciąży kobiety często intensywnie szukają informacji i bardzo szybko mogą trafić na treści budzące niepokój. Warto powiedzieć pracownikowi medycznemu, z jakimi źródłami miałaś kontakt – czy były to wpisy w mediach społecznościowych, artykuły, opinie znajomych czy prywatne doświadczenia innych mam. Takie otwarte postawienie sprawy pomaga specjaliście odnosić się do konkretnych wątpliwości i oddzielić fakty naukowe od niezweryfikowanych treści, które mogą podsycać lęk.

5. Poproś o wskazanie sprawdzonych źródeł wiedzy dotyczących szczepień w ciąży

Warto poprosić pracownika medycznego o listę miejsc, w których znajdziesz aktualne i wiarygodne informacje na temat szczepień dla kobiet w ciąży. Mogą to być strony internetowe instytucji zdrowia publicznego, rekomendacje towarzystw naukowych, materiały przygotowane przez organizacje specjalizujące się w edukacji zdrowotnej czy broszury udostępniane w gabinetach. Dzięki temu będziesz mogła samodzielnie poszerzać wiedzę i czuć się pewniej, wiedząc, że materiały są zweryfikowane i aktualne.

6. Zabierz ze sobą dokumentację – kartę ciąży, wcześniejsze wyniki badań lub informacje o szczepieniach z przeszłości

Dokumenty te pozwalają pracownikowi medycznemu ocenić Twoje indywidualne potrzeby. Informacje o przebiegu ciąży, chorobach, przyjmowanych lekach czy przebytych szczepieniach w przeszłości pomagają stworzyć bezpieczny i dostosowany plan szczepień. Nawet drobny szczegół może mieć znaczenie, dlatego warto mieć dokumentację przy sobie.

7. Zapytaj o możliwe przeciwwskazania oraz typowe reakcje po szczepieniu

W okresie ciąży wiele kobiet czuje naturalną potrzebę przewidywalności i jasności. Dlatego warto zapytać, jakie są typowe reakcje organizmu po danym szczepieniu, jak długo mogą trwać i w jakiej sytuacji zgłosić się na kontrolę. Wiedza o tym, co jest normalne, pozwala przejść przez proces ze spokojem i bez zbędnego stresu.

8. Jeśli szczepienie nie może zostać wykonane, poproś o omówienie alternatywnych form ochrony

Zdarzają się sytuacje, w których stan zdrowia lub okoliczności ciąży nie pozwalają na wykonanie konkretnego szczepienia. Warto wtedy zapytać o inne możliwości ochrony, na przykład o szczepienie osób z Twojego najbliższego otoczenia, o ograniczenie ekspozycji czy o dodatkowe środki ostrożności. Pracownik medyczny może zaproponować rozwiązania, które mimo braku szczepienia nadal obniżą ryzyko zachorowania.

9. Informuj o wszystkich objawach infekcji, nawet jeśli wydają Ci się nieistotne

Kwalifikacja do szczepienia w ciąży wymaga ostrożności, dlatego bardzo ważne jest, abyś mówiła o każdym objawie, który może wskazywać na infekcję lub osłabienie organizmu. To nie tylko kwestia procedur, ale

przede wszystkim Twojego bezpieczeństwa. Pracownik medyczny oceni, czy szczepienie powinno zostać przełożone, czy jest możliwe do wykonania.

10. Planuj szczepienia z wyprzedzeniem, aby organizm miał czas na wytworzenie odporności

Wiele szczepień zalecanych w ciąży ma określone ramy czasowe – na przykład najlepszy trymestr lub konkretne tygodnie ciąży. Warto więc myśleć o nich wcześniej, szczególnie jeśli planujesz wyjazdy, zmiany miejsca pracy lub kontakt z większą liczbą osób. Pamiętaj, że organizm potrzebuje czasu, aby zareagować na szczepienie i wytworzyć przeciwciała chroniące Ciebie i dziecko.

11. Bądź otwarta na sugestie pracownika medycznego i traktuj rozmowę jako wspólny proces podejmowania decyzji

W okresie ciąży łatwo ulec poczuciu, że musisz znać wszystkie odpowiedzi i że każda decyzja musi zapaść natychmiast. Warto pamiętać, że pracownik medyczny jest osobą, która ma nie tylko wiedzę, ale również doświadczenie oraz dostęp do aktualnych wytycznych dotyczących szczepień w ciąży. Jeśli więc podczas rozmowy otrzymasz sugestię zmiany terminu, wyboru innej szczepionki lub dodatkowego badania, dobrze jest potraktować to jako element troski o Twoje bezpieczeństwo, a nie jako ograniczenie. Rozmowa o szczepieniach powinna być dialogiem, w którym obie strony wspólnie szukają najlepszego rozwiązania.

12. Jeśli informacje, które przeczytałaś w Internecie różnią się od tego, co słyszysz od specjalisty, poproś o wyjaśnienie, a nie kwestionuj od razu jego kompetencji

Ciąża to czas ogromnej wrażliwości na niejednoznaczne przekazy. Jeśli trafiałaś wcześniej na treści, które wydają się sprzeczne z tym, co mówi pracownik medyczny, warto otwarcie o tym porozmawiać. Często różnice

wynikają z tego, że internetowe treści są wyrwane z kontekstu albo dotyczą starszych, już nieaktualnych zaleceń. Zdarza się również, że odnoszą się do sytuacji klinicznych, które nie mają zastosowania w ciąży. Pracownik medyczny może wytłumaczyć, skąd biorą się te rozbieżności i dlaczego w Twojej sytuacji rekomenduje konkretne postępowanie. To buduje zaufanie i pozwala uniknąć niepotrzebnych emocji.

13. Przygotuj się na to, że niektóre pytania pracownika medycznego mogą być bardzo osobiste i dotyczą sposobu życia, ale są one ważne dla Twojego bezpieczeństwa

Szczepienia w ciąży czasem wymagają szerszego kontekstu – na przykład informacji o podróżach, kontaktach z innymi osobami, obecności zwierząt domowych, pracy w środowisku o zwiększonym ryzyku zakażeń czy chorobach występujących w najbliższej rodzinie. Dla wielu kobiet pytania te mogą być zaskakujące lub krępujące, ale nie są zadawane bez powodu. Ich celem jest dobranie najlepszego i najbezpieczniejszego schematu postępowania. Warto patrzeć na nie nie jak na ocenę, lecz jak na element rzetelnej opieki.

14. Zapytaj o indywidualny plan szczepień na całą ciążę, a nie tylko na najbliższą wizytę

Pracownicy medyczni mają wiedzę na temat tego, które szczepienia są szczególnie istotne w ciąży i w jakim okresie przynoszą najwięcej korzyści. Warto więc porozmawiać o harmonogramie całej ciąży, ustalając, w których tygodniach najlepiej wykonać konkretne szczepienie, aby zapewnić maksymalny poziom ochrony. Taki plan daje poczucie bezpieczeństwa, pozwala przygotować się organizacyjnie i zmniejsza stres związany z podejmowaniem decyzji „pod presją czasu”.

15. Jeśli w Twoim życiu zaszły istotne zmiany – przeprowadzka, zmiana pracy, opieka nad starszym dzieckiem – poinformuj o tym, bo może to wpływać na zalecenia

Rzeczywistość codzienna ma ogromne znaczenie dla decyzji o szczepieniach w ciąży. Zmiana środowiska pracy może wiązać się z większym narażeniem na choroby zakaźne. Przeprowadzka do innego regionu lub częstsze podróże mogą zwiększyć ryzyko kontaktu z patogenami. Opieka nad małym dzieckiem, które uczęszcza do żłobka lub przedszkola, również może być istotna. Im lepiej pracownik medyczny zna Twoją sytuację, tym trafniej może dopasować rekomendacje.

16. Jeśli zdecydujesz się wykonać szczepienie, poproś o szczegółowe wyjaśnienie zaleceń dotyczących czasu po szczepieniu

Wiele kobiet obawia się, jak zachowywać się po szczepieniu w ciąży – czy można prowadzić samochód, ćwiczyć, korzystać z sauny, pracować fizycznie czy podróżować. Warto dopytać o wszystkie te aspekty, aby po szczepieniu nie odczuwać niepewności. Pracownik medyczny wyjaśni, które aktywności są w pełni bezpieczne, a które warto na kilka dni ograniczyć. Dzięki temu proces szczepienia przebiega spokojniej i z większym poczuciem kontroli.

17. Poproś o informację, które objawy po szczepieniu są całkowicie normalne, a które powinny skłonić Cię do kontaktu z gabinetem lub wizyty kontrolnej

Świadomość typowych reakcji organizmu – lekkiego bólu ręki, zmęczenia czy podwyższonej temperatury – pozwala uniknąć zbędnego niepokoju. Jednocześnie warto wiedzieć, które objawy wymagają reakcji. Pracownik medyczny może przekazać Ci wytyczne, dzięki którym będziesz mogła zareagować szybko i właściwie, jeśli cokolwiek wzbudzi Twoje wątpliwości. To niezwykle istotny element poczucia bezpieczeństwa w ciąży.

18. Jeśli coś Cię martwi po szczepieniu, nie wahaj się skontaktować z lekarzem – to część normalnej opieki

W ciąży wiele kobiet doświadcza zwiększonej czujności wobec swojego ciała i reakcji organizmu. Jeśli cokolwiek po szczepieniu będzie dla Ciebie niepokojące, warto skonsultować to z lekarzem. Nie jest to oznaka przesadnej ostrożności – to naturalna część dbania o zdrowie swoje i dziecka. Specjalista może ocenić, czy objawy mieszczą się w normie, czy wymagają osobistej wizyty.

19. Warto pamiętać, że szczepienia w ciąży są jednym z najlepiej przebadanych elementów opieki prenatalnej i mają na celu zarówno ochronę Ciebie, jak i dziecka

Dobrze jest rozmawiać o tym otwarcie z pracownikiem medycznym – o tym, dlaczego konkretne szczepienia są rekomendowane, jakie badania stoją za tymi zaleceniami oraz jaką rolę pełnią przeciwciała przekazywane dziecku przez łożysko. Ta rozmowa często pomaga rozwiać najgłębsze obawy i zrozumieć, że szczepienia nie są decyzją podjętą „na wszelki wypadek", lecz procedurą mającą solidne, naukowe podstawy.

20. Zadbaj o swoją wiedzę i nie bój się wracać do tematu szczepień w kolejnych wizytach – ciąża jest dynamicznym procesem, a potrzeby mogą się zmieniać

Ciąża nie jest stanem statycznym – w każdym trymestrze pojawiają się nowe wyzwania i pytania. To naturalne, że wątpliwości mogą pojawiać się ponownie. Warto więc traktować rozmowy o szczepieniach jak ciągły proces, a nie jednorazową konsultację. Pracownicy medyczni są po to, aby wspierać Cię na każdym etapie i pomagać podejmować decyzje, które będą najlepsze zarówno dla Ciebie, jak i dziecka.

Rozmowa o szczepieniach w okresie ciąży jest jednym z najważniejszych elementów odpowiedzialnej troski o zdrowie własne i zdrowie dziecka.

To moment, w którym rzetelna wiedza, wsparcie pracownika medycznego oraz Twoje świadome zaangażowanie spotykają się we wspólnym celu – zapewnienia możliwie najlepszej ochrony w czasie, gdy odporność organizmu odgrywa kluczową rolę.

Dlatego tak ważne jest, aby o szczepieniach rozmawiać otwarcie, zadawać pytania, wyjaśniać wątpliwości i korzystać ze wsparcia osób, które mają wiedzę i doświadczenie: położnych, pielęgniarek, lekarek i lekarzy, farmaceutów oraz innych pracowników medycznych. Nie musisz znać odpowiedzi na wszystkie pytania – Twoją rolą jest zadbać o siebie i dziecko, a rolą profesjonalistów jest dostarczyć Ci informacji i zaproponować rozwiązania oparte na aktualnych rekomendacjach.

Podejmowanie decyzji zdrowotnych w ciąży to proces, który wymaga czasu, spokoju i zaufania. Dobrze przeprowadzona rozmowa z pracownikiem medycznym może przynieść ulgę, zbudować pewność siebie i dać jasne poczucie, że działasz w zgodzie z najlepszą wiedzą medyczną. To właśnie ta współpraca – Twoja uważność i kompetencje osób sprawujących nad Tobą opiekę – tworzą fundament bezpiecznej i świadomej profilaktyki w tym szczególnym okresie życia.

9. Piśmiennictwo

1. Amirthalingam G. i wsp. Pertussis immunization and control in England and Wales, 1957 to 2012: a historical review. Euro Surveill. 2013;18:1-9.
2. Dodds L. i wsp. Impact of influenza exposure on rates of hospital admissions and physician visits because of respiratory illness among pregnant women CMAJ 2007;176:463-8.
3. Donaldson B. i wsp. What determines uptake of pertussis vaccine in pregnancy? A cross sectional survey in an ethnically diverse population of pregnant women in London. Vaccine 2015;33:5822-8.
4. Donegan K i wsp. Safety of pertussis vaccination in pregnant women in UK: observational study. BMJ. 2014;349:g4219:1-6.
5. Fell D.B. i wsp. H1N1 influenza vaccination during pregnancy and fetal and neonatal outcomes. Am J Public Health. 2012;102:e33-40.
6. Gall S.A. i wsp. Maternal immunization with tetanus-diphtheria-pertussis vaccine: effect on maternal and neonatal serum antibody levels. Am J Obstet Gynecol. 2011;204:334.e1-5.
7. Håberg S.E. i wsp. Risk of fetal death after pandemic influenza virus infection or vaccination. N Engl J Med 2013;24:368:333-40.
8. Halperin B.A. i wsp. Kinetics of the antibody response to tetanus--diphtheria-acellular pertussis vaccine in women of childbearing age and postpartum women. Clin Infect Dis. 2011;53:885-92.
9. Hauge S.H. i wsp. Influenzae hospitalizations during childhood in children born preterm. Influenza Other Respir Viruses 2022; 16(2): 247-254.
10. Healy C.M. i wsp. Importance of timing of maternal Tdap immunization and protection of young infants. Clin Infect Dis 2013;56:539-44.
11. Hisano M. i wsp. Usefulness of influenza vaccination during pregnancy to mothers and young infants. Expert Review of Vaccines 2012;11:903-5
12. Kharbanda E.O. i wsp. Maternal Tdap vaccination: coverage and acute safety outcomes in the vaccine safety datalink, 2007-2013. Vaccine 2016;34:968-73.
13. Mertz D. i wsp. Populations at risk for severe or complicated influenza illness: systematic review and metaanalysis. Br Med J 2013;347:f5061.

14. Moro P.L. i wsp. Adverse events in pregnant women following administration of trivalent inactivated influenza vaccine and live attenuated influenza vaccine in the Vaccine Adverse Event Reporting System, 1990-2009. Am J Obstet Gynecol 2011;204:146.
15. Pasternak B. i wsp. Vaccination against pandemic A/H1N1 2009 influenza in pregnancy and risk of fetal death: cohort study in Denmark. BMJ 2012;344:e2794.
16. Pérez Marc G. i wsp. Real-world effectiveness of RSVpreF vaccination during pregnancy against RSV-associated lower respiratory tract disease leading to hospitalisation in infants during the 2024 RSV season in Argentina (BERNI study): a multicentre, retrospective, test-negative, case-control study. Lancet Infect Dis, 2025: S1473-3099(25)00156-2.
17. Puleston R. i wsp. Multi-centre observational study of transplacental transmission of influenza antibodies following vaccination with AS03(A)-adjuvanted H1N1 2009 vaccine. PLoS One 2013;8:e47448.
18. Safety of immunization during pregnancy. A review of the evidence. Global Advisory Committee on Vaccine Safety. WHO, 2014.
19. Shakib J.H. i wsp. Influenza in Infants Born to Women Vaccinated During Pregnancy. Pediatrics 2016;137:6.
20. Shakib J.H. i wsp. Tetanus, Diphteria, Acellular pertussis vaccaine during pregnancy: pregnancy and infant health outcomes. J Pediatr 2013; 163:1422-6.
21. Steinhoff M.C. i wsp. Neonatal outcomes after influenza immunization during pregnancy: a randomized controlled trial. CMAJ 2012;184:645-53.
22. Sukumaran L. i wsp. Association of Tdap vaccination with acute events and adverse birth outcomes among pregnant women with prior tetanus--containing immunizations JAMA 2015;314:1581-7.
23. Thompson M.G. i wsp. Influenza Vaccine Effectiveness in Preventing Influenza-associated Hospitalizations During Pregnancy: A Multi-country Retrospective Test Negative Design Study, 2010–2016. Clinical Infectious Diseases, 2019, 68, 9, 1, 1444–1453.
24. Zheteyeva Y.A. i wsp. Adverse event reports after tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid, and acellular pertussis vaccines in pregnant women. Am J Obstet Gynecol 2012;207(59)e1-7.

szczepienia info

BAZA WIEDZY O SZCZEPIENIACH KOBIET W CIĄŻY

– SIĘGNIJ PO WIARYGODNE ŹRÓDŁO INFORMACJI

szczepienia.pzh.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia

NPZ NARODOWY PROGRAM ZDROWIA

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.